

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Consultorio Endocrino-Obstétrico

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	29 años
Estado civil:	Casada
Ocupación:	Diseñadora gráfica
Fecha de elaboración:	12/02/2026

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Diagnóstico previo de tiroiditis de Hashimoto desde 2019, en tratamiento con levotiroxina 75 mcg/día. Último control endocrino hace 8 meses. No otras enfermedades crónicas.

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G2 P0+1 (1 aborto espontáneo 2023 a las 8 semanas, sin causa identificada).

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	10/10/2025
FPP:	17/07/2026
EG actual (por FUM):	18 semanas
Controles prenatales:	4 al momento
Diagnóstico nuevo:	Hipotiroidismo descompensado en gestación

Paciente refiere fatiga progresiva, intolerancia al frío y aumento de peso inusual desde inicio del embarazo. Niega palpitaciones, temblor o pérdida de peso. Movimientos fetales aún no percibidos (acorde a EG).

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PA 108/68 mmHg. FC 64 lpm (bradicardia relativa). T° 36.2°C. Peso 65.5 kg (aumento de 3 kg en 6 semanas). Piel seca y fría. Bocio difuso grado I no doloroso. AU 16 cm. LCF 152 lpm.

LABORATORIOS TIROIDEOS (10/02/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
TSH	8.5	mUI/L	Elevada (meta gestacional <2.5)
T4 libre	0.7	ng/dL	Disminuida (rango 0.93-1.7)
Anti-TPO	245	UI/mL	Elevado — autoinmunidad confirmada
T3 total	85	ng/dL	Limítrofe bajo

OTROS LABORATORIOS (10/02/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	11.9	g/dL	Dentro de rango
Glucosa basal	82	mg/dL	Normal
HIV (ELISA)	No reactivo	—	Negativo
Sífilis (RPR)	No reactivo	—	Negativa

PLAN

1. Ajuste de dosis de levotiroxina: aumentar a 125 mcg/día (incremento del 60-80% sobre dosis pregestacional según guías ATA). 2. Control de TSH y T4 libre en 4 semanas. Meta TSH gestacional <2.5 mUI/L. 3. Educación sobre adherencia y toma de levotiroxina en ayunas. 4. Eco obstétrica del segundo trimestre programada en 2 semanas. 5. Suplementación con yodo + ácido fólico + hierro según pauta de alto riesgo. 6. Interconsulta con endocrinología.

Documento generado para fines de prueba del clinical-extractor de SICA. Sintético. No representa una paciente real.